

TEMA 5.18 • OFTALMOLOGÍA

retinopatía hipertensiva

PERFIL EUNACOM 6.02.1.027

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patologías de Órbita y Proptosis

Saber diferenciar y enfocar el origen profundo de un aumento masivo de la presión del cono y caja ósea orbitaria es vital cuando enfrentamos un **Exoftalmos o Proptosis protruyente visible**.

1. Orbitopatía Distiroidea

Se le asocia ineludiblemente al hipertiroidismo de origen y linaje primariamente auto-inmune. - **Etiología Específica:** Se da estrictamente en el contexto y base de la patología hiperfuncional de **Enfermedad de Graves-Basedow**. Su mecanismo fundamental no es originado per sé por la hormona hiperactiva basal tiroidea (ya que no tienen relación proporcional en severidad) sino porque los anticuerpos estimulantes TSH (*Anticuerpos TRAB*) interactúan reaccionariamente cruzados con los receptores IGF-1 periféricos del fibroblasto estimulando descontroladamente un edema celular craso retro-ocular retrobulbar enorme subiendo contenido perimetral de músculo ciliar con depósito de muco-polisacáridos basales desbordando las órbitas y traccionando a exteriorización pasiva limitante los propios ojos hacia delante y expuestas afuera. - **Clínica Cardinal:** - Exoftalmos / Proptosis francamente marcado (Unilateral o masivamente más frecuentemente bilateral de asimetría relativa dependiente). - Aparición tardía o temprana de *Diplopía restrictiva gruesa* en extremas por falla general elongada limitante del traccionamiento de rectos. - Provocación de resecamiento focal general anterior general derivando de forma secundaria la Ojo Seco expuesta grave (*Ojo: en E. de Graves, la simple alteración neurológica de aumento catecolaminérgica de Retracción estriada Palpebral no es la orbitopatía per sé, esa revierte con betabloqueos, pero la exoftalmía biológica de aumento en grasa retroocular requiere moduladores*). - **Diagnóstico y Evaluación Auxiliar General:** - Solicitar fundamental base clínica autoinmune Perfil Tiroideo completo funcional de tamizaje base para hiperacción autoinmune global (**TSH caída en el suelo inhibida + T4 Libre severamente alzada y Anticuerpos TRAB Positivos obligatoria**). - Evaluación Topográfica Radiológica de rigor perimetral anatómica formal (*TC TAC de Órbita ósea base biótica*) visibilizando patognomónica franca el engrosamiento en vientres fusiformes en cono sin compromiso tendinoso de inserción y de infiltraciones grasa del recubrimiento base en tejido intra/extra conal y nervio retro-visual empujado fuertemente y tensado para evaluar riesgos perimétricos ciegos o compresión local masiva basal del fascículo ocular final del sujeto limitante al cerebro posterior. - **Tratamiento Focal y Progresivo y Evolutivo:** Puede estabilizarse con regresión sola natural discreta en observación oftalmológica. Si el cuadro exoftálmico avanza implacablemente maligno muy disfuncionante limitando u arriesgando al segundo nervio con visión borrosa profunda severa e incapacitando dolor intenso, obligan perimetralmente administrar terapias corticoesteroidales altas por pulsos endovenosos masivos (ej: base Metilprednisolona Intravenosa). Alternativas especializadas base a subespecialidad: Bloqueo anti receptor autoinmune molecular (*Tepezza / Teprotumumab*) biótico o intervenciones puramente de Cirugía focal orbitaria externa osteoclástica descompresiva basal profunda.

2. Pseudotumor Orbitario Idiopático Inespecífico

- **Definición Ocular Médica:** Entidad de clínica perimetral orbital base, inflamación agresivamente orbitaria indistinguible general de exoftalmía grave retrobulbar masiva general. - **Clave EUNACOM diferenciadora:** Es exactamente la misma clínica de la anterior con

sus síntomas de proptosis focal general. PERO cursa lógicamente siempre en perfil general con un **Absoluto recuento metabólico hormonal normal y pruebas bioquímicas de TSH o función Tiroídea negativa completamente**. Resultando idiopático de origen y respondiendo idénticamente de base cortico-sensible temporal profunda.

3. Esbozo sobre Neoplasias Oculares Severas de Urgencias Periféricas Base

Dependen estrictamente del territorio base epitelial embrionario comprometido perimetral en localización y etiologías funcionales. Los tumores bióticos oftálmicos abarcan la semiología topográfica general externa y la semiología fondo y neurológica oculta endógena limitando la visión desde lo hondo perimetral central profunda hasta la superficie ocular exterior.

- **Tumores de Órbita base de encrucijada base cono profunda:** La clínica limitante dominante expansivamente progresiva exterior e intratable y más lenta siempre cursará ineludiblemente con una Proptosis focal crónica pasiva lenta perimetral. Estanco diagnosticado inicial requeridamente obligatorio base con el escaneo *TAC Tomografía perimetral maxilofacial contrastada órbita* buscando focal tumor expansivo crónico (Hemangiomas capilares o masa linfóide orbitaria posterior crónica en adultos mayores limitantes o Rabdomyosarcomas devastadores graves urgentes agudísimos destructivos perimetrales musculares niños inespecíficos pediátricos perimetrales).
- **Tumores de Globo Ocular internos formales Endógenos Retinianos Profundos Puros Pediátricos Graves Perimetrales:** Su hallazgo letal universal base debut perimetral general inespecífico a toda observación incidental pediátrica recae sin duda en la **Leucocoria Ocular Temprana Limitante (o Estrabismo repentino adquirido de mal fijación infantil generalizada tardía secundaria)** revelando obligadamente descartes con Ecografías base del ojo y el gran y el mortal agresor local de diagnóstico final clínico letal del **Retinoblastoma general en edad de niños precoces inicial**.
- **Tumores de Anexos Periféricos Limitados Oculares Base y Conjuntivas Exocervicales Cutáneas Focales Expuestas Exteriores Clásicos Histológicos:** Poseen exactamente un asimilable espectro funcional biológico idéntico natural morfológicamente general al de etiología natural cutánea dérmica basal de piel humana universal dermatológica de fotoexposición al UV base perimetral; derivando en su mayor volumen predecible estadísticamente basales a generalidad base formales limitadas exterior simples de *Carcinomas Basocelulares locales crónicos*, Carcinomas Espinocelulares hiperkeratósicos actínicos gruesos periféricos y los tristes y gravísimos oscuros y agresivos generalizados periféricos Melanomas Conjuntivales difusos de alta metástasis base general inespecífica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un médico realiza fondo de ojo a un paciente hipertenso de cincuenta y ocho años en control. Observa engrosamientos en los puntos donde las arteriolas cruzan las vénulas retinianas, con muescas visibles en las venas en esos cruces. ¿Cuál es el hallazgo y qué indica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para retinopatía hipertensiva. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La retinopatía hipertensiva es completamente asintomática y su importancia es como marcador del daño de órgano blanco por hipertensión.
- El diagnóstico se hace con el fondo de ojo, que visualiza directamente los vasos retinianos y sus alteraciones.
- Los hallazgos más característicos son los cruces arteriovenosos o signo de Gunn-Salus, casi exclusivos de la retinopatía hipertensiva.
- La progresión arteriolar va desde aumento del reflejo, a hilo de cobre, luego hilo de plata y finalmente cordón fibroso.
- Las hemorragias en llama son características de la retinopatía hipertensiva y de la oclusión de la vena central de la retina, no de otras retinopatías.
- El tratamiento es el control de la hipertensión arterial con antihipertensivos; en casos muy agresivos pueden requerirse fármacos endovenosos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RETINOPATÍA HIPERTENSIVA)**PREGUNTA 1**

Un médico realiza fondo de ojo a un paciente hipertenso de cincuenta y ocho años en control. Observa engrosamientos en los puntos donde las arteriolas cruzan las vénulas retinianas, con muescas visibles en las venas en esos cruces. ¿Cuál es el hallazgo y qué indica?

- A)** Microaneurismas retinianos; indica retinopatía diabética proliferativa
- B)** Signo de Gunn-Salus o cruces arteriovenosos; indica retinopatía hipertensiva como marcador de daño de órgano blanco
- C)** Exudados algodonosos; indica isquemia retiniana por retinopatía diabética
- D)** Hemorragias en llama; indica oclusión de la vena central de la retina
- E)** Drusas maculares; indica degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 2

En la evolución progresiva del daño arteriolar en la retinopatía hipertensiva, ¿cuál es el orden correcto de la progresión del aspecto de las arteriolas retinianas?

- A)** Hilo de plata → hilo de cobre → aumento del brillo → cordón fibroso
- B)** Aumento del brillo arteriolar → hilo de cobre → hilo de plata → cordón fibroso
- C)** Cordón fibroso → hilo de plata → hilo de cobre → aumento del brillo
- D)** Hilo de cobre → aumento del brillo → cordón fibroso → hilo de plata
- E)** Todos los cambios aparecen simultáneamente sin un orden determinado

PREGUNTA 3

Un paciente hipertenso grave es evaluado con fondo de ojo y se observan hemorragias en llama en la retina. ¿Cuál es el significado clínico específico de las hemorragias en llama en el contexto de la retinopatía hipertensiva?

- A)** Son patognomónicas de la retinopatía diabética proliferativa
- B)** Son características de la retinopatía hipertensiva y de la oclusión de la vena central de la retina
- C)** Son hallazgos normales sin significado patológico en hipertensos mayores de sesenta años
- D)** Son exclusivas de la hipertensión maligna y nunca se ven en hipertensión crónica
- E)** Son idénticas a las hemorragias en llamarada de la retinopatía diabética proliferativa

RESUMEN: RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

La retinopatía hipertensiva es el daño retiniano producido por la hipertensión arterial crónica. Su característica clínica más importante es que es absolutamente asintomática: el paciente no tiene síntomas oculares. Su importancia radica en que es un marcador del daño de órgano blanco por la hipertensión, ya que si la retina está dañada, es muy probable que otros órganos como el riñón, el cerebro y el corazón también estén comprometidos. El diagnóstico se hace con el fondo de ojo, que permite visualizar directamente los vasos retinianos. Los hallazgos más característicos y exclusivos de la retinopatía hipertensiva son los cruces arteriovenosos o signo de Gunn-Salus, que se producen porque las arterias y las venas retinianas comparten la adventicia, y cuando la arteria engrosada por la hipertensión comprime la vena en el cruce, se produce una muesca visible. La progresión del daño arteriolar se sigue por el brillo de las arteriolas: primero aumenta el reflejo arteriolar, luego las arteriolas se vuelven como hilo de cobre y finalmente como hilo de plata, hasta llegar a ser un cordón fibroso totalmente ocluido. También pueden aparecer hemorragias en llama, exudados algodonosos o duros, y microaneurismas, pero estos se ven en otras retinopatías también. Lo que es casi exclusivo de la retinopatía hipertensiva son las hemorragias en llama y los cruces arteriovenosos. La retinopatía hipertensiva es el marcador clásico de la hipertensión maligna. El tratamiento es el control de la hipertensión arterial con antihipertensivos.